

Plan profilaktyki nawrotów

Po remisji ryzyko nawrotu wynosi 50–80 %. Plan profilaktyki redukuje je o połowę. Tworzy się go **przed** zakończeniem terapii.

CZAS: 2–3 sesje w fazie końcowej Plan na 12 mies. po remisji

ŹRÓDŁO: Beck (1979); Hollon i wsp. (2005); Kuyken i wsp. (2016, MBCT); Vittengl i wsp. (2007, metaanaliza)

JAK UŻYWAĆ

W fazie końcowej terapii (po osiągnięciu remisji) **zaprojektuj plan** obejmujący 4 elementy (sekcja 01-04): (1) *mapa moich wzorców* — co u mnie zwiastuje nawrót, (2) *narzędzia, które działają* — sprawdzone w terapii, (3) *plan działania na 3 poziomach* nasilenia, (4) *kontakty wsparcia*. Zapisz, wydrukuj, trzymaj w widocznym miejscu. Cel: *plan*, nie zaufanie pamięci.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Depresja jest **chorobą nawrotową** (Hollon i wsp. 2005): po 1 epizodzie ryzyko nawrotu = 50 %, po 2 epizodach = 70 %, po 3+ = 80–90 %. Vittengl i wsp. (2007) w metaanalizie 28 RCT: **strategie profilaktyki nawrotów** (ang. *relapse prevention*) redukuje ryzyko o 22 % w 1 rok, 14 % w 2 lata. Kuyken i wsp. (2016): MBCT z planem profilaktyki obniża ryzyko o **43 %**. Mechanizm: plan działa *przed* tym, jak depresja zniekształci poznawanie — gdy zaczynasz spadać, mózg traci zdolność do mądrych decyzji („nic mi już nie pomoże, nawet to”). *Wcześniej* zaprojektowany plan pozwala działać *mimo* depresji. Beck (1979): pacjenci, którzy *nie mają* planu, częściej trafiają do szpitala — bo nie wiedzą, kiedy „to jest nawrót”, reagują za późno.

01 = Moje typowe wzorce nawrotu

CO ZWYKLE URUCHAMIA MÓJ NAWRÓT?

— wyzwalacze życiowe

MOJE PIERWSZE MYŚLI OSTRZEGAWCZE

— jakie zdania wracają

MOJE PIERWSZE ZACHOWANIE OSTRZEGAWCZE

— co robię, gdy zaczyna się depresja

MOJE TYPOWE OBJAWY CIELESNE

— sen, energia, apetyt

02 ● Narzędzia, które u mnie działają

Z całej terapii wybierz **5 narzędzi**, które najwyraźniej u Ciebie zadziałały. To *twoja apteczka*.

1.

2.

3.

4.

5.

03 ● Plan działania — 3 poziomy nasilenia

● POZIOM 1 · SYGNAŁY

3–7 dni gorszego nastroju

Wzmacniam **podstawy**: sen (#24), ruch (#25), kontakt (#27), światło (#28). Wracam do dziennika myśli (#5). 1–2 tyg. utrzymuję wzmocnienie.

MOJA KONKRETNA LISTA

● POZIOM 2 · NASILENIE

2+ tyg. objawów

Wracam do terapii (booster session). Dzwonię do swojego psychoterapeuty / lekarza. Aktywuję pełną apteczkę narzędzi. Mówię bliskim.

MÓJ KONTAKT + TELEFON

● POZIOM 3 · PEŁNY NAWRÓT

myśli o śmierci, niezdolność funkcjonowania

Pełna interwencja: psychiatra, lek, intensyfikacja terapii. Plan SOS (#35). Bliscy aktywują wsparcie 24/7. Bez ukrywania.

MÓJ PSYCHIATRA + TELEFON

04 ● Sieć wsparcia — 3 osoby

NAJBLIŻSZA OSOBA

— *która wie o terapii*

DRUGA OSOBA

— *wsparcie zapasowe*

TRZECIA OSOBA

— *jeśli inni niedostępni*

Wydrukuj ten plan i trzymaj w widocznym miejscu: na lodówce, w portfelu, na biurku. *Nie polegaj na pamięci* — gdy zaczyna się nawrót, mózg traci zdolność do mądrych decyzji. Plan jest *twoim wcześniejszym ja*, które rozmawia z *twoim aktualnym, gorszym ja*. Kuyken (2016): pacjenci, którzy mieli wydrukowany plan, reagowali na sygnały *5–10 dni szybciej* niż ci bez planu — różnica między „2-tygodniowy spadek” a „4-miesięczny epizod”. Powtarzaj plan co 6 mies. — aktualizuj wyzwacze i narzędzia.